

1. Introducción y relevancia clínica

El **consumo de alcohol** es el trastorno por sustancias **más prevalente en Chile y en el mundo**, con importantes repercusiones sanitarias, familiares y sociales.

Según la **Encuesta Nacional de Salud (ENS 2022)**, alrededor del **11% de los chilenos presenta consumo problemático o dependencia del alcohol**.

El alcoholismo tiene un impacto transversal:

- Aumenta el riesgo de **traumatismos, cirrosis, pancreatitis, cáncer, depresión y suicidio**.
- Es causa frecuente de **consultas en urgencia por intoxicación aguda o síndrome de abstinencia**.

En el **EUNACOM**, los casos suelen incluir:

- Paciente hospitalizado que presenta **temblores, agitación, sudoración o convulsiones**.
- Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico y manejo inicial más adecuado?
- O bien, manejo de la **intoxicación etílica aguda con depresión del sensorio**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo de acción del alcohol

El **etanol** actúa principalmente como **depresor del sistema nervioso central**, potenciando la neurotransmisión **GABAérgica (inhibitoria)** y **bloqueando la glutamatérgica (excitatoria, NMDA)**.

- ↑ GABA → sedación, euforia, incoordinación.
- ↓ Glutamato → inhibición cortical, deterioro cognitivo.

Con el consumo crónico:

- El cerebro **reduce la sensibilidad a GABA y aumenta la actividad glutamatérgica** como compensación.
 - Al suspender bruscamente el alcohol, ocurre un **rebote excitatorio** → **síndrome de abstinencia**.
-

2.2. Neuroadaptación y dependencia

- **Tolerancia:** se requiere mayor cantidad de alcohol para lograr el mismo efecto.
 - **Dependencia física:** aparición de síntomas al suspender el consumo.
 - **Dependencia psicológica:** necesidad subjetiva de beber para funcionar o aliviar ansiedad.
-

2.3. Efectos metabólicos

- El etanol se metaboliza en el **hígado** por la **alcohol deshidrogenasa (ADH)** → acetaldehído → ácido acético.
 - La **acumulación de NADH** altera el metabolismo glucídico y lipídico → **hipoglicemia, esteatosis hepática, acidosis láctica**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Intoxicación alcohólica aguda

Depende de la concentración plasmática (mg/dL):

Nivel	Manifestaciones
50–100	Euforia, desinhibición, disminución del juicio

100–200 Ataxia, disartria, nistagmo, somnolencia

200–300 Confusión, vómitos, diplopía

300–400 Estupor, hipotermia, bradipnea

>400 Coma y riesgo vital (depresión respiratoria)

Diagnóstico diferencial:

- Hipoglicemia.
- Intoxicación por benzodiazepinas o barbitúricos.
- Traumatismo craneoencefálico.

☐ En pacientes inconscientes: siempre descartar **TEC + hipoglicemia**, antes de atribuir al alcohol.

3.2. Síndrome de abstinencia alcohólica (SAA)

Aparece **6–24 horas** después de la última ingesta en consumidores crónicos.

Síntomas iniciales:

- Ansiedad, insomnio, sudoración, náuseas.
- Temblores finos, taquicardia, hipertensión.
- Hiperreflexia, agitación.

Síntomas severos:

- **Convulsiones tónico-clónicas generalizadas** (12–48 h).
- **Alucinosis alcohólica:** alucinaciones visuales o táctiles sin confusión.
- **Delirium tremens:** forma más grave, con compromiso de conciencia.

3.3. Delirium tremens (DT)

Emergencia médica vital.

Aparece entre **48–96 h** tras suspensión del consumo.

Clínica:

- Desorientación, agitación intensa.
- Alucinaciones visuales o zoopsias (“bichos, animales pequeños”).
- Temblores, diaforesis, fiebre.
- Hipertensión, taquicardia, deshidratación.
- Riesgo de arritmias, muerte súbita o paro cardiorrespiratorio.

Mortalidad sin tratamiento: 20%; con manejo adecuado <5%.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Intoxicación aguda

- **Alcohol en sangre:** correlación con síntomas.
 - **Glicemia capilar:** descartar hipoglicemia.
 - **Electrolitos, función hepática y renal.**
 - **Gasometría:** acidosis metabólica frecuente.
 - **ECG:** descartar arritmias.
-

4.2. Síndrome de abstinencia

- **Clínica:** diagnóstico esencialmente clínico.

- Escalas de severidad: **CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol)**.
 - **Laboratorio:** hemograma, electrolitos, Mg, Ca, glucosa, transaminasas.
-

4.3. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Rasgo distintivo
Delirium por otras causas	No hay historia reciente de suspensión de alcohol
Esquizofrenia	Psicosis sin alteración de conciencia ni signos autonómicos
Epilepsia	Convulsiones sin síntomas vegetativos previos
Intoxicación por estimulantes	Hiperactividad sin historia de abstinencia alcohólica

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

5.1. Intoxicación aguda

Objetivo: estabilización y prevención de complicaciones.

1. **Soporte vital básico (ABCDE).**
 - Vía aérea permeable.
 - Monitoreo cardíaco y saturación O₂ .
2. **Glicemia capilar:** administrar **tiamina 100 mg EV antes de glucosa** (prevención del síndrome de Wernicke).
3. **Hidratación IV** con suero fisiológico.

4. **Evitar flumazenilo o antagonistas específicos.**
5. **Si agitación:** benzodicepinas (lorazepam o diazepam).

5.2. Síndrome de abstinencia alcohólica (SAA)

Hospitalización en casos moderados a graves, convulsiones o delirium.

a.

Benzodicepinas (fármaco de elección)

- **Diazepam:** 10–20 mg VO/EV cada 4–6 h según escala CIWA.
- Alternativa: **lorazepam** (más seguro en hepatópatas).
- Disminuir gradualmente en 5–7 días.

b.

Vitaminas y soporte

- **Tiamina 100 mg/día EV o VO.**
- **Ácido fólico y complejo B.**
- Hidratación y corrección de electrolitos.

c.

Anticonvulsivantes

- No de rutina. Solo si convulsiones recurrentes.

d.

Antipsicóticos (haloperidol)

- Solo si alucinaciones o agitación severa **posterior a control autonómico.**

5.3. Delirium tremens

Emergencia vital → hospitalización en UCI.

1. **Diazepam EV** a dosis altas (10–20 mg cada 1–2 h).
 2. Si no responde → **midazolam o propofol en UCI**.
 3. **Tiamina EV**, luego glucosa.
 4. **Control hidroelectrolítico** riguroso (K, Mg).
 5. **Monitoreo cardíaco y ventilatorio**.
-

5.4. Tratamiento a largo plazo (deshabitación)

El objetivo es prevenir recaídas y promover abstinencia.

a.

Psicoterapia y programas comunitarios

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC) y entrevista motivacional.**
- **Grupos de ayuda mutua:** Alcohólicos Anónimos (AA).
- **Programas MINSAL:** COSAM, Hospital de Día, Rehabilitación en APS.

b.

Farmacoterapia de mantenimiento

Fármaco	Mecanismo	Dosis	Observaciones
Disulfiram	Inhibe aldehído deshidrogenasa → reacción aversiva al alcohol	250 mg/día VO	Requiere alta motivación y abstinencia previa
Naltrexona	Antagonista opioide: reduce craving y placer por alcohol	50 mg/día VO	Bien tolerado

Acamprosato	Modula GABA y glutamato: mantiene abstinencia	666 mg VO c/8h	Evitar en insuficiencia renal
--------------------	---	-------------------	-------------------------------

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones médicas

- Hepatitis y cirrosis alcohólica.
 - Cardiomiopatía dilatada.
 - Neuropatía periférica.
 - Pancreatitis crónica.
 - **Síndrome de Wernicke-Korsakoff** (deficiencia de tiamina).
 - Desnutrición y anemia megaloblástica.
-

6.2. Pronóstico

Depende del **grado de dependencia** y **soporte social**.

- Con tratamiento integral y apoyo familiar: **50–60% logran abstinencia parcial o total**.
 - Recaídas frecuentes en los primeros 6 meses.
 - Pronóstico mejor con **intervención temprana y motivación alta**.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Siempre administrar **tiamina antes de glucosa** en pacientes alcohólicos.
 2. El **tratamiento del síndrome de abstinencia** es con **benzodicepinas**, no antipsicóticos en primera línea.
 3. **Delirium tremens = urgencia vital → UCI.**
 4. En hepatópatas, preferir **lorazepam** sobre diazepam.
 5. **Naltrexona y acamprosato** reducen recaídas a largo plazo.
 6. **Disulfiram** solo si el paciente está motivado y bajo supervisión.
 7. **Alucinaciones visuales** sin confusión → alucinosis alcohólica; con confusión → delirium tremens.
-



Errores comunes

- Dar glucosa antes de tiamina → riesgo de **encefalopatía de Wernicke**.
 - Suspender bruscamente benzodicepinas durante abstinencia.
 - No identificar **signos autonómicos** (taquicardia, hipertensión) como inicio de abstinencia.
 - Tratar la agitación del DT solo con haloperidol.
 - No derivar a programa de rehabilitación tras el alta.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **alcoholismo** es una enfermedad crónica con dependencia física y psicológica.
2. La **intoxicación aguda** puede producir depresión respiratoria y coma.
3. El **síndrome de abstinencia** aparece 6–24 h después de la última ingesta.

4. **Delirium tremens** es una emergencia vital: fiebre, agitación, confusión, alucinaciones visuales.
5. El tratamiento de elección es con **benzodiacepinas + tiamina**.
6. La **tiamina debe administrarse antes de glucosa**.
7. La rehabilitación integral (farmacológica + psicosocial) es esencial para mantener abstinencia.